

Fecha Última Actualización: 14-11-2022 6:38:11

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Maria Antonia Lara Ruz
Edad : 68a 9m 27d
Dirección : Tolpan 899

Rut : 6.922.757-0
Fecha Nacto: 18/01/1954
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A248448
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5440 1006

N° Epicrisis
330114

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Ingreso : 07/10/2022 01:51

Días Estadía: 38

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 14/11/2022 06:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS HOSPITALARIA
14/11/2022
María Lara Ruz

Fecha Ingreso HSR: 07/10/22
Fecha Ingreso UTIM 4to piso: 13/10/22
Fecha Ingreso UTIM 5to piso Mater: 25/10/22
Fecha de ingreso UCI: 31/10/2022
Fecha de fallecimiento: 14/11/2022 05:35 AM

Antecedentes patológicos personales

- LES/ AR/ Sjögren
- Hipertensión pulmonar grupo I asociada a enfermedad de tejido conjuntivo
- DM2 IR
- Osteoporosis severa
- Necrosis avascular de cabeza de fémur Izquierdo
- HTA
- Hipotiroidismo
- Anemia crónica multifactorial
- ITU previa KPN BLEE+
- Cesárea
- Niega tabaco, alcohol y otras drogas
- Alergia a: dipirona y N-Butilbromuro de Hioscina

Medicación habitual

- Prednisona 5mg día
- Ambrisentan 10x/día
- Hidroxicloroquina 200mg/día
- Sildenafil 50mg 3x/día
- Losartán 50mg/día

Fecha Epicrisis : 14/11/2022 06:38

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:15

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

- Espironolactona 25mg/día
- Furosemida 40mg/día
- Azatioprina 100mg/día
- Digoxina 0.125/día
- Levotiroxina 75 mcg/día
- Omeprazol 40mg/día
- Insulina

Motivo de ingreso a UCI

- Neumonía grave, intrahospitalaria, en paciente inmunocomprometida por AR / lupus / Sjögren
- o Falla respiratoria aguda hipoxémica
- o Falla hemodinámica
- TEP
- Cetoacidosis diabética

Paciente con antecedentes descritos, ingresa el 07/10/2022 a UTIM cuarto piso de este centro asistencial por deterioro del sensorio interpretado en contexto de hiponatremia y proceso expansivo supraselar (obs. Craneofaringioma) detectado por TC de cerebro; sin indicación quirúrgica urgente, el 09/10 se realiza RNM de cerebro y silla turca (informe pendiente).

Mantuvo terapia para Hipertensión pulmonar con Ambrisentan y Sildenafil

Intercurrencias:

- El 12/10 intercorre con neumonía aspirativa, inicia ampicilina sulbactam con mala respuesta, se escala el 15/10 a MERO; cultivos sin rescate microbiológico. Completó 7 días de dicho antibiótico.
- Natremia fluctuante sintomática (hiponatremia e hipernatremia hasta 160) de difícil control, se interpretó en contexto de panhipopituitarismo y diabetes insípida central por tumor cerebral en el quiasma, inició desmopresina intranasal, intercurrió con hiponatremia reaccional profunda y oliguria que obliga a su suspensión. TSH baja, IGF-1 en rango y PRL elevada (88).
- Delirium que se controló con risperidona.
- El 25/10/2022 PCR SARS-CoV-2 (+), por lo que se traslada a UTIM para manejo en cama con aislamiento respiratorio, inicia corticoides según protocolo RECOVERY.

Evoluciona con falla respiratoria progresiva, con PaFi hasta 125, con canula nasal de alto flujo 50/ FiO2 55%, mala mecánica ventilatoria, en ese contexto se realiza TC de tórax el 31/10/2022 que reporta:

- Signos de tromboembolismo pulmonar bilaterales según lo descrito, sin signos de sobrecarga ventricular derecha.
 - Neumopatía multifocal con focos de condensación bilaterales de predominio en lóbulos inferiores, de mayor extensión que en estudio previo, de posible origen inflamatorio-infeccioso.
- Requiere intubación orotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica.

En ese contexto ingresa a UCI.

Al examen físico, se presenta sedanalgesiada hasta RASS -2, con fentanilo, pupilas isocóricas, hiporreactivas, intubada, se conecta a ventilación mecánica protectora, Vc 270 ml (6.4 ml Kg peso ideal), PEEP 7, FR 24, FiO2 70%, sin mayor conflicto de mecánica ventilatoria, P meseta 17, PEEP total 8, DP 9, CRO 30, a la auscultación crepitantes en ambas bases de predominio derecho, abdomen blando, depresible, RHA disminuidos, extremidades simétricas.

Bajo normas de asepsia y antisepsia y guía ecográfica se coloca CVC yugular derecho, acceso difícil, al primer pinchazo, sin interurrencias.

Bajo normas de asepsia y antisepsia y guía ecográfica se coloca línea arterial femoral izquierda, acceso difícil, al segundo pinchazo, sin interurrencias.

Evolución durante estadía en UCI

· Neurológico: Se mantuvo sedada en contexto de shock séptico y falla ventilatoria con Fentanilo/Midazolam/Propofol, requiriendo de forma intermitente BNM con Rocuronio. Con natremias de difícil manejo en contexto de diabetes insípida conocida secundaria a craneofaringeoma que requirieron freno de diuresis con Desmopresina. Al momento de suspender sedación, paciente no logró recuperar conciencia y conectarse, durante la ventana de 72 horas en las que su estado clínico permitió suspender sedación.

· Hemodinámico: Presentó 2 episodios de shock séptico. En primera instancia secundario a neumonía intrahospitalaria de su ingreso a la unidad, con requerimientos de NAD a dosis moderadas con rápida suspensión posterior. Segundo episodio

Fecha Última Actualización: 14-11-2022 6:38:11

Página 3 de 4

secundario a NAVM, este más profundo y con requerimientos de NAD a dosis altas, asociado a FOM.

·Respiratorio: A su ingreso presentó falla respiratoria de etiología múltiple; NIH, TEP e HTP. Con buena respuesta a VMI y BNM. Posteriormente y en contexto de NAVM presentó nuevamente deterioro ventilatorio con alteración severa de intercambio gaseoso, requiriendo BNM. Control con TAC de tórax el 13/11 presenta mayor extensión de focos de condensación bi basales en contexto de NAVM.

·Infeccioso: Neumonía intrahospitalaria de ingreso no se aisló microbiología y completó terapia empírica con carbapenémicos más Vancomicina con buena respuesta. Sobre infección, neumonía asociada a ventilación mecánica, se aisló una PSA (R) a carbapenémicos por lo cual se inició tratamiento con Colistin con regular respuesta.

Medio interno: Paciente con natremias de muy difícil manejo. Durante estadía en UCI presentó normalización de natremias hasta descompensación asociada a NAVM. El 13/11 presenta hipernatremia hasta 178 con Diu de 3.390 cc, siendo manejado con Desmopresina con buena respuesta y volemicación. Adicionalmente en contexto de FOM por shock séptico inició AKI oligoanúrica.

Gastrointestinal/Quirúrgico: Día 13/11 se controla TAC de abdomen que demuestra gran fecaloma con distensión en recto bajo y signos sugerentes de perforación. Evaluado por residencia de cirugía impresiona dudosa perforación, la cual en caso de existir impresionaría más bien estar autocontenida. Adicionalmente paciente extremadamente grave para ingresar a pabellón con pronóstico de sobrevida definido por otros factores. Se realiza extracción manual, dando salida a abundantes deposiciones de carácter blando.

Paciente fallece el 14/11 a las 05:35, se da aviso a familiares y se entrega certificado de defunción.

Diagnósticos de egreso de UCI

Shock séptico

- Falla orgánica múltiple: compromiso renal, hematológico, hemodinámico y ventilatorio.

Neumonía asociada a ventilación mecánica por PSA (R) a carbapenémicos

Hipernatremia severa asociada a diabetes insípida

Fecaloma, obs perforación de recto bajo

Neumonía intrahospitalaria sin microbiología aislada recuperada

Tumor cerebral

Obs craneofaringeoma

Panhipopituitarismo

ISR central vs por corticoides

Hipotiroidismo

NAC COVID-19 en paciente inmunosuprimido (PCR + 24/10)

Neumonía aspirativa.

TEP

LPP sacra GI

Antecedentes: LES/AR/Sjogren, Hipertension pulmonar grupo I asociada a Enf tejido conjuntivo, DM2 IR, Osteoporosis severa, Necrosis avascular de cabeza de femur I, HTA, hipotiroidismo, Anemia crónica multifactorial, ITU previa KPN BLEE+

Diagnóstico de Egreso

Shock septico -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Se realiza certificado de defunción. Se entrega a familiares.

Plan Post Alta

Se realiza certificado de defunción. Se entrega a familiares.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Fecha Epicrisis : 14/11/2022 06:38

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:15

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 14-11-2022 6:38:11

Página 4 de 4

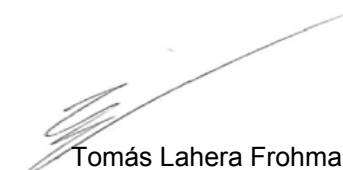
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Tomás Lahera Frohmann

Médico Tratante (Staff)